

Podłoże *uzależnień*

Biologia (50–60% dziedziczności), środowisko (mechanizm zmiennego wzmocnienia zaprojektowany celowo), trauma rozwojowa, kultura — nakładają się i tworzą podatność. To nie kwestia silnej woli.

CZAS: 15 min Wersja edukacyjna **ŹRÓDŁO:** Potenza (2015); Slutske (2010); Eyal (2014)

JAK UŻYWAĆ

1 · Poznasz cztery filary podłoża uzależnień behawioralnych (sekcja 01): biologia, środowisko, trauma, kultura. **2** · Zrozumiesz, na czym polega *zmiennie wzmocnienie* (sekcja 02) — najsilniejszy mechanizm warunkowania w psychologii, wykorzystywany celowo przez przemysł hazardowy, gry i aplikacje. **3** · Sprawdzisz *swój* profil ryzyka (sekcja 03). **4** · Zobaczysz, dlaczego destygmatyzacja jest warunkiem skutecznego leczenia (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Uzależnienia behawioralne mają *wspólną* neurobiologię z uzależnieniami od substancji. Potenza (2015), Grant & Chamberlain (2014) w neuroobrazowaniu funkcjonalnym (fMRI) wykazali, że hazard, granie kompulsywne i CSBD aktywują **tę samą sieć**: brzuszny obszar nakrywki (VTA) → jądro półleżące (NAcc) → kora przedczołowa (PFC) — z hipoaktywacją PFC (osłabiona kontrola) i hiperaktywacją prążkowia (wzmóŜona reaktywność na bodźce). Slutske i wsp. (2010) w badaniu bliźniąt obliczyli **dziedziczność hazardu patologicznego na 50-60%** — porównywalną z uzależnieniem od alkoholu. Polimorfizm DRD2 (Lobo 2012) jest *wspólnym* czynnikiem ryzyka dla hazardu i alkoholizmu, co tłumaczy nakładanie się tych zaburzeń. Środowisko: dostępność online 24/7 (kasyna, gry, pornografia) zmienia ekspozycję; przemysł celowo wykorzystuje *zmiennie wzmocnienie* (Eyal 2014, *Hooked*). Trauma: niekorzystne doświadczenia dzieciństwa (ACEs) zwiększają ryzyko uzależnień behawioralnych analogicznie do uzależnień substancyjnych. Współwystępowanie: ADHD (impulsywność), depresja (ucieczka), lęk społeczny (granie/pornografia jako „bezpieczna” alternatywa relacji). *Konsekwencja kliniczna*: walka z uzależnieniem behawioralnym to walka asymetryczna — pacjent *kontra* branża warta bilionów dolarów. „Brak silnej woli” jest **falszywą diagnozą**.

01

Cztery filary podłoża

1 · BIOLOGIA + GENETYKA

dziedziczność 50–60%

Slutske 2010: dziedziczność hazardu porównywalna z uzależnieniem od alkoholu. Polimorfizm DRD2 (Lobo 2012) — wspólny czynnik ryzyka behawioralnych i substancyjnych. Sieć VTA-NAcc-PFC z osłabioną kontrolą prefrontalną.

2 · ŚRODOWISKO + DESIGN

dostępność 24/7, celowy design

Eyal 2014, „Hooked”: aplikacje są *zaprojektowane* wokół zmiennego wzmocnienia (variable ratio). Kasyna online, lootboxy, lajki na social mediach, mikrotransakcje. Mózg nie wie, kiedy nagroda — chroniczne oczekiwanie.

3 · TRAUMA ROZWOJOWA

ACEs zwiększają ryzyko

Niekorzystne doświadczenia dzieciństwa (ACEs: przemoc, zaniedbanie, uzależnienia w rodzinie, śmierć opiekuna) zwiększają ryzyko uzależnień behawioralnych. Mechanizm: regulacja emocji + niezaspokojone potrzeby relacyjne.

4 · KULTURA + WSPÓŁWYSTĘPOWANIE

normalizacja, ADHD, depresja, lęk

Gloryfikacja hazardu (celebryci pokera), e-sportów, „grindowania”. Współwystępowanie: ADHD (impulsywność), depresja (ucieczka), lęk społeczny (granie i pornografia jako bezpieczna alternatywa relacji).

02 ◎ Zmienne wzmocnienie — najsilniejszy mechanizm warunkowania

Skinner (1953) wykazał, że *zmienny stosunek wzmocnień* (variable ratio) jest **najsilniejszym** wzorcem warunkowania — silniejszym niż stała nagroda. Branża hazardowa, gier i social mediów celowo wykorzystuje ten mechanizm.

HAZARD

Automaty, ruletka, zakłady — nieprzewidywalna nagroda, near-miss, dźwięki. Branża kasynowa ma działały badawcze zatrudniające neuronaukowców.

GRY KOMPUTEROWE

Lootboxy (paczki z losową zawartością), gacha, sezony, drop rare itemów. Belgia i Holandia (2018) zakazały lootboxów jako hazardu.

SOCIAL MEDIA

Lajki, powiadomienia, „pull to refresh”. Każde otwarcie aplikacji = potencjalna nagroda. Nieskończone przewijanie.

03 ✎ Mój profil ryzyka

Im więcej ✓, tym *większa podatność biologiczna i środowiskowa*. To **nie** jest diagnoza — to mapa czynników, na które warto zwrócić uwagę.

BIOLOGIA + GENETYKA

- ☐ W rodzinie były problemy z uzależnieniami (alkohol, hazard, narkotyki)
- ☐ Mam zdiagnozowane ADHD (zespół nadpobudliwości)
- ☐ Mam tendencję do impulsywnych decyzji w innych obszarach
- ☐ Lubię silne bodźce / „adrenalinę”

TRAUMA + EMOCJE

- ☐ Doświadczyłem/-am traumy w dzieciństwie (przemoc, zaniedbanie, strata)
- ☐ Mam objawy depresji lub lęku
- ☐ Czuję się samotny/-a — mało kontaktów offline
- ☐ Mam trudność z regulacją emocji

ŚRODOWISKO + DOSTĘPNOŚĆ

- ☐ Aplikacje hazardowe / gry / pornografia na telefonie w zasięgu ręki
- ☐ Spędzam >3h dziennie na social mediach lub w aplikacjach z powiadomieniami
- ☐ W moim otoczeniu hazard / granie / pornografia są normalizowane
- ☐ Pracuję w stresie, mało snu, mało aktywności fizycznej

WZORCE ZACHOWANIA

- ☐ Wracam do zachowania, mimo postanowień, że ograniczę
- ☐ Potrzebuję coraz „mocniejszych” wersji (większe stawki, więcej czasu, mocniejsze treści)
- ☐ Ukrywam zachowanie przed bliskimi
- ☐ Po epizodzie czuję wstyd, pustkę albo poczucie winy

04 🔍 Destygmatyzacja — warunek skutecznego leczenia

MIT, KTÓRY BLOKUJE LECZENIE

„Mam słabą wolę. Wystarczy się ogarnąć.” Lub: „To tylko gra / hobby / przyjemność — nie ma się o co martwić.” Minimalizacja jest częstsza niż osąd — i równie szkodliwa.

CO DZIAŁA ZAMIAST

„To zaburzenie z udokumentowaną biologią. ICD-11 uznaje hazard i granie kompulsywne. Pomoc jest skuteczna — CBT, dialog motywujący, w niektórych przypadkach farmakoterapia.” Uznanie + plan + wsparcie.

Klucz: walka z uzależnieniem behawioralnym to *walka asymetryczna*. Po jednej stronie jesteś Ty — z mózgiem, który ma 50–60% dziedzicznej podatności, z historią i z emocjami. Po drugiej — branża hazardowa, gier i social mediów warta bilionów dolarów, zatrudniająca neuronaukowców do *maksymalizacji* mechanizmu zmiennego wzmocnienia (Eyal 2014). „Brak silnej woli” jest **falszywą diagnozą**. To *nie* jest słabość — to konsekwencja biologii + środowiska + projektu. Pomoc istnieje (CBT, MI, ew. naltrekson dla hazardu i CSBD, N-acetylocysteina dla parcia) — i jest skuteczna (Cowlshaw 2012, $d = 0,74$ dla hazardu; Hallberg 2019, $d = 0,66$ dla CSBD; Stevens 2021, $d = 0,57$ dla zaburzenia gamingowego).